

Un adulto nel vostro ambulatorio

Per medici di famiglia e professionisti sanitari — nella cura di un adulto autistico occupato.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adulto si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Nell'ambiente giusto ciò dà vere punti di forza — concentrazione sostenuta, affidabilità, rilevamento di pattern, profondità e onestà. In quello sbagliato (uffici open-space, interruzioni costanti, aspettative poco chiare, politica d'ufficio) guida a esaurimento cronico, mascheramento e **burnout autistico**. Molti adulti autistici che lavorano — specialmente donne — sono stati diagnosticati solo in età adulta. Un appuntamento di 15 minuti mostra raramente il vero costo.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Esausto, non si riprende dopo il lavoro, perde abilità	Burnout autistico — distinto dal burnout lavorativo e dalla depressione
Ansia, umore basso, problemi di sonno o gastrointestinali	Co-occorrenze e segnali di sovraccarico comuni
„Bene” in ambulatorio, crolla per giorni dopo	Forte mascheramento ; il vero costo si paga fuori vista
Non riferisce dolore, sintomi o effetti collaterali finché non sono gravi	Differenze di interocezione — i segnali interni possono non registrarsi quando è assorbito
Vuole le email invece delle chiamate; vuole le cose per iscritto	La comunicazione a canale singolo, letterale riduce il carico

Provate questo

- **Offrite l'AHAT di AASPIRE** pre-visita e opzioni **scritte in primo luogo**; permettete un accompagnatore.
- **Riconoscete il burnout autistico** — esaurimento cronico, perdita di funzione, ridotta tolleranza agli stimoli — e non confondetelo con depressione o pigrizia.
- **Chiedete del carico lavorativo e del recupero**: open-space, riunioni, interruzioni, mascheramento.
- **Iniziate i farmaci a dosi basse e titolate lentamente** — gli adulti autistici riferiscono spesso risposte sensoriali/emotive atipiche.
- **Segnalate gli adeguamenti lavorativi** (Equality Act / ADA) e suggerite che la persona è l'esperta di cosa aiuta.

Evitate questo

- Trattare il burnout come depressione e spingere il paziente a „sforzarsi di più” o a mascherare di più — questo lo approfondisce e aumenta il rischio di suicidio.
- Lasciare che 15 minuti calmi e mascherati prevalgano sull'auto-riferimento e sull'anamnesi.
- Dare per scontato che „non si lamenta” significhi „non soffre”.

Quando serve altro supporto

Valutate la **suicidalità** — il burnout vi è collegato. Affrontate le condizioni co-occorrenti **ADHD (AuDHD), ansia, depressione, sonno e gastrointestinali**. Dove il burnout è severo, validate il **riposo o aspettative ridotte** come passo di recupero, non debolezza. Documentate gli adeguamenti efficaci così che siano automatici la prossima volta.

Se il paziente è una donna

Le donne sono sovrarappresentate nella „generazione perduta” di adulti diagnosticati tardi e mascherano di più. Prendete sul serio uno schema di vita di differenze sociali/sensoriali ed esaurimento privato, anche con un’esteriorità „di successo”.

Informazioni su questa guida

*Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la sintesi sul **Monotropismo** e la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parti 3.4 e 4). Usa il linguaggio con l’identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela al/dalla singolo/a.*

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Mantzalas et al. (2022, fattori protettivi del burnout); Pearson & Rose (2021, mascheramento); Knight (2021); Kelly Mahler (2024, interocezione); AASPIRE AHAT. Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.